

اسپوندیلوآرتروپاتی

۱- بیمار آقای ۲۴ ساله با سابقه کمردرد التهابی از دو سال قبل، از درد پاشنه پا و قفسه سینه شکایت دارد. در معاینه آتریت آرنج چپ و تست پاتریک دوطرفه مثبت است. برای تشخیص بیماری ایشان، کدام رادیوگرافی را پیشنهاد می‌کنید؟

(الف) قفسه سینه

(ب) آرنج

(ج) لگن

(د) پاشنه پا

پاسخ تشریحی: گزینه ج

بر اساس شرح حال و یافته‌های معاینه بیمار ۲۴ ساله شما که شامل کمردرد التهابی، درد پاشنه پا، درد قفسه سینه، آتریت آرنج و تست پاتریک (FABER) دوطرفه مثبت است، این مجموعه از علائم به شدت مطرح کننده یک بیماری از گروه اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها (SpA) است. تست پاتریک مثبت به خصوص درگیری مفصل ساکروایلیاک را مطرح می‌کند.



در تشخیص اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها، یافته‌های رادیوگرافیک نقش مهمی دارند. از بین یافته‌های رادیوگرافیک در این گروه از بیماری‌ها، ساکروایلیت یک علامت اصلی و کلیدی محسوب می‌شود، به ویژه در اسپوندیلیت انکیلوزان (AS) که یکی از انواع اصلی SpA است. رادیوگرافی مفاصل ساکروایلیاک که بخشی از لگن هستند، برای مشاهده تغییرات ساختاری مانند اسکروز، اروژن‌ها و فیوژن در این مفاصل استفاده می‌شود. با توجه به کمردرد التهابی و تست پاتریک مثبت در بیمار شما که مطرح کننده درگیری ساکروایلیاک است، رادیوگرافی لگن برای بررسی این مفاصل از اهمیت بالایی برخوردار است.

۲- کدام جمله در مورد HLA-B۲۷ صحیح نیست؟

- الف) جزئی از مولکول MHC-II می باشد.
- ب) ساختمان آن شامل سه زنجیره آلفا و یک β ۲ می باشد.
- ج) رسپتور سطحی سلول التهابی مثل لنفوسیت است.
- د) در AS مستعد میس فولدینگ است.

پاسخ تشریحی: الف در جزوه به طور مستقیم نیست

الف: HLA-B۲۷ یک مولکول کلاس I از MHC است، نه کلاس II.

MHC کلاس I در تمامی سلول های نوکله دار دیده می شود و به CD۸+ T cells ارائه آنتی ژن می دهد.

ب: مولکول های MHC کلاس I، شامل یک زنجیره α ۱، α ۲، و یک β ۲ میکروگلوبولین هستند.

ج: MHC کلاس I از جمله HLA-B۲۷ به عنوان آنتی ژن پرنزنتینگ مولکول در سطح سلول های بدن (از جمله سلول های ایمنی) دیده می شود.

د: HLA-B۲۷ به دلیل ساختار خاص خود، مستعد misfolding و ایجاد پاسخ های التهابی غیر طبیعی در اسپوندیلیت آنکیلوزان است.

۳- آقای ۲۵ ساله با درد و تورم و قرمزی مچ پای راست و زانوی راست از ده روز قبل مراجعه کرده است. وی سه هفته قبل سابقه ای از گاستروآنتریت می دهد که پس از پنج روز بهبود یافته است. کدام جمله در مورد ایشان درست نیست؟

- الف) ممکن است زخم دهانی بدون درد داشته باشد.
- ب) کشت مایع مفصل ارگاناسم روده ای را نشان می دهد.
- ج) HLA-B۲۷ (می تواند مثبت باشد).
- د) بیماری ایشان طی ۳-۵ ماه معمولاً بهبود می یابد.

پاسخ تشریحی: گزینه ب

بر اساس شرح حال بیمار ۲۵ ساله با سابقه گاستروآنتریت اخیر که با شروع حاد آرتریت نامتقارن در مفاصل تحتانی (مچ پا و زانو) مراجعه کرده است، تشخیص مطرح در ایشان آرتریت واکنشی (Reactive Arthritis - ReA) است. این بیماری به عنوان یک عارضه عفونی به دنبال عفونت در نقاط دیگر بدن، از جمله عفونت های روده ای، رخ می دهد.

الف: ضایعات پوستی مخاطی (Mucocutaneous lesions) از تظاهرات بالینی آرتریت واکنشی هستند. به طور خاص، "زخم های دهانی که بدون درد هستند" و "اروزیون هایی با مرزهای مشخص در کام سخت: شایعترین تظاهر دهانی در ReA یاد شده.

ب: مایع مفصلی در آرتریت واکنشی "غیر چرکی و استریل" است. اگرچه آنتی ژن های میکروارگاناسم های عامل مانند یرسینیا، کلامیدیا، سالمونلا و شینگلا در سینوویوم دیده شده اند و حتی DNA یا RNA کلامیدیا تراکوماتیس و یرسینیا در مایع سینوویال با روش PCR قابل شناسایی بوده اند اما تأکید

می‌شود که کشت مایع مفصل برای این ارگانیزم‌ها "غیر اختصاصی و بدون اهمیت در بالین" است و صرفاً اهمیت تحقیقاتی دارد. استریل بودن مایع مفصل به این معنی است که کشت میکروبی معمولاً منفی خواهد بود.

ج: درصد مثبت بودن آن در یافته‌های جدیدتر کمتر از تخمین‌های قبلی است ۳۰-۵۰٪ در بیماران اما امکان مثبت بودن HLA-B۲۷ در بیماران مبتلا به ReA وجود دارد.

د: آرتریت در جریان ReA معمولاً ۳ تا ۵ ماه طول می‌کشد آن resolve شود البته البته در جزوه ذکر شده است که در ۱۵٪ بیماران علائم مفصلی مزمن می‌شوند و امکان عود نیز وجود دارد.

۴- در کدام بیمار زیر احتمال مثبت شدن HLA B۲۷ کمتر است؟

الف) خانم ۳۵ ساله با کمردرد التهابی و درد پاشنه پا و سابقه پسوریازیس

ب) آقای ۲۲ ساله با سابقه کمردرد التهابی و ساکروایلایت دو طرفه در رادیوگرافی

ج) آقای ۴۵ ساله با سابقه بیماری کرون و پلی‌آرتریت

د) خانم ۲۷ ساله با سابقه آرتریت زانوهای یک هفته پس از اورتریت

پاسخ تشریحی: گزینه ج

الف: این شرح حال به نفع آرتریت پسوریاتیک (Psoriatic Arthritis - PsA) با درگیری محوری (کمردرد التهابی) و انتزیت (درد پاشنه) است شیوع HLA-B۲۷ در بیماران پسوریاتیک با درگیری محوری ۷۰ تا ۹۰٪ است.

ب: این شرح حال کاملاً منطبق بر آنکیلوزینگ اسپوندیلیت (Ankylosing Spondylitis - AS) آشکار (radiographic axial SpA) است شیوع HLA در بیماران AS بسیار بالا، یعنی ۹۰ تا ۹۲٪ است.

ج: این شرح حال به نفع آرتریت انتروپاتیکی (Enteropathic Arthritis) مرتبط با بیماری التهابی روده (IBD) است. در این بیماری، بین درگیری محوری شبیه AS و درگیری محیطی (پلی‌آرتریت یا اولیگوآرتریت) تمایز قائل می‌شوند و اگر بیمار IBD و تنها درگیری مفاصل محیطی داشته باشد HLA-B۲۷ ۱۵ تا ۲۰٪ مثبت می‌شود.

د: این شرح حال بسیار به نفع آرتریت واکنشی (Reactive Arthritis - ReA) به دنبال عفونت اوروژنیتال (اورتریت) است شیوع HLA در این بیماران ۳۰-۵۰٪ ذکر شده

۵- خانم ۳۸ ساله‌ای به علت درد در باتوک راست و مفاصل متعدد دست مراجعه کرده است. در معاینه، التهاب در مفاصل DIP هر دو دست و برخی از PIP ها، کوتاه شدن انگشت سوم هر دو دست، سوسیس شدن انگشت دوم راست وجود دارد. همچنین ضایعات اریتماتو پوسته‌ریزی‌دهنده در سطح اکستانسور دیده می‌شود و در برخی ناخن‌ها هیپرکراتوز و فرو رفتگی (pitting) مشاهده می‌گردد.

کدام درگیری زیر در ایشان مشخصه (Characteristic) است؟

- الف) داکتیلیت
- ب) کوتاه شدن انگشت
- ج) درگیری DIP
- د) درگیری PIP

پاسخ تشریحی: گزینه ب

بر اساس شرح حال ارائه شده، بیمار خانم ۳۸ ساله‌ای با علائم درد کمر درد التهابی (درد باتوک راست) و آرتریت در مفاصل محیطی مفاصل دست، به خصوص DIP و PIP، داکتیلیت انگشت، کوتاه شدن انگشت و همچنین یافته‌های پوستی و ناخنی سازگار با پسوریازیس (ضایعات اریتماتو پوسته‌ریزی‌دهنده در سطح اکستانسور، هیپرکراتوز و فرو رفتگی ناخن) مراجعه کرده است. این مجموعه علائم به شدت مطرح کننده تشخیص آرتریت پسوریاتیک (Psoriatic Arthritis - PsA) است.

الف: داکتیلیت به التهاب کامل یک انگشت دست یا پا گفته می‌شود که منجر به نمای "سوسیسی" انگشت می‌شود. در شرح حال بیمار به "سوسیس شدن انگشت دوم راست" اشاره شده است. داکتیلیت در آرتریت واکنشی (ReA) و آرتریت پسوریاتیک (PsA) دیده می‌شود.

ب: در شرح حال بیمار به "کوتاه شدن انگشت سوم هر دو دست" اشاره شده است. در نوع مخرب آرتریت پسوریاتیک (Arthritis Mutilans)، مفاصل دچار دفورمیتی و استئولیز (از بین رفتن استخوان) می‌شوند که منجر به پدیده‌ای به نام "انگشت تلسکوپی" و کوتاه شدن انگشت می‌شود جزوه صراحتاً تأکید می‌کند که این یک یافته Characteristic است.

ج: اگرچه در آرتریت پسوریاتیک دیده می‌شود، ولی به تنهایی ویژگی تمایزدهنده‌ای محسوب نمی‌شود

د: درگیری مفاصل پروگزیمال بین انگشتی (PIP) در آرتریت پسوریاتیک، به خصوص در فرم پلی‌آرتریت (%۴۰ موارد)، دیده می‌شود. با این حال، درگیری PIP یک تظاهر شایع در بسیاری از آرتریت‌های دیگر مانند RA نیز هست و به اندازه درگیری DIP یا داکتیلیت، مشخصه PsA نیست.

۶- کدام اختلال زیر جز تظاهرات آرتریت پسوریاتیک نمی‌باشد؟

- الف) نفرس
- ب) یوویت
- ج) نارسایی آئورت
- د) کلاپینگ

پاسخ تشریحی: گزینه د

الف: در بیماران مبتلا به پسوریازیس (که ممکن است آرتریت پسوریاتیک نیز داشته باشند)، سطح اسید اوریک ممکن است به دلیل متابولیت‌های حاصل از سلول‌های مرده پوستی افزایش یابد و باعث هایپراوریسمی شود و ایجاد نقرس شود

ب: درگیری چشمی در آرتریت پسوریاتیک به عنوان یک تظاهر خارج مفصلی یاد شده، در آرتریت پسوریاتیک، یووئیت می‌تواند به شکل خلفی و دوطرفه باشد و پروگنوز بدتری نسبت به نوع قدامی و یک‌طرفه شایع در AS داشته باشد

ج: اگرچه ممکن است کمتر از AS شایع باشد، اما نارسایی آئورت می‌تواند به عنوان یک تظاهر مرتبط با آرتریت پسوریاتیک بروز پیدا کند.

د: کالبینگ (Clubbing) به عنوان یکی از تظاهرات خارج روده‌ای بیماری التهابی روده (IBD)، به خصوص در بیماری کرون اما این عارضه در بیماران مبتلا به آرتریت پسوریاتیک دیده نمی‌شود.

۷- کدام یک از موارد زیر با درد مکانیکی متفاوت دارد؟

الف) تشدید صبحگاهی ۱۵ دقیقه

ب) وجود پوزیشن بدون درد

ج) بدتر شدن درد با حرکت

د) دردی که باعث بیدار شدن در نیمه شب می‌شود

پاسخ تشریحی: گزینه د

تفاوت های درد التهابی با مکانیکی:

• سن شروع معمولاً کمتر از ۴۰ سال است. درد مکانیکی معمولاً بعد از ۴۵ سالگی شایع‌تر است

• شروع تدریجی دارد. درد مکانیکی اغلب شروع حاد یا مرتبط با یک رویداد خاص دارد

• با فعالیت بهتر می‌شود. درد مکانیکی با فعالیت بدتر می‌شود

• با استراحت بهتر نمی‌شود. درد مکانیکی با استراحت بهتر می‌شود

• دردی است که بیمار را از خواب بیدار می‌کند. به خصوص در نیمه دوم شب. درد مکانیکی معمولاً باعث بیدار شدن از خواب در شب نمی‌شود یا کمتر شایع است

• خشکی صبحگاهی بیشتر از ۳۰ دقیقه دارد، که ممکن است تا چند ساعت طول بکشد. درد مکانیکی ممکن است خشکی صبحگاهی کوتاه‌تری داشته باشد

• درد متناوب در ناحیه پاتاک (باسن) دارد

با این توضیحات گزینه د جواب است.

۸- آقای ۶۰ ساله با تورم و درد مفاصل مچ دست‌ها و متاکارپوفالانژیال و زانو‌ها از ۱۰ سال قبل به شما مراجعه می‌نماید. در معاینه: آرتریت مفصل، $Hb=10$ ، $ESR=70$ ، $RF+$ ، $Anticcp+$ بوده است. در رادیوگرافی به عمل دست بیمار، کدام یک از موارد زیر به ضرر تشخیص می‌باشد؟



الف) انکیلوز

ب) اوروزیون

ج) اسکروز استخوان ساب‌کندرال

د) استئوپنی ژوکتا آرتیکولار

پاسخ تشریحی: گزینه ج

شرح حال و یافته‌های بیمار (آرتریت مزمن با درگیری مفاصل کوچک دست، RF و $Anti-CCP$ مثبت، ESR بالا و آنمی (کاملاً با آرتریت روماتوئید (RA) سازگار است. در تصویربرداری بیماران مبتلا به RA، یافته‌هایی مانند:

- اروسین‌ها: (Erosions) تخریب حاشیه‌ای استخوان
- استئوپنی پیرامفصلی: از بین رفتن تراکم استخوان اطراف مفصل
- تنگی فضای مفصلی

شایع‌اند. ولی اسکروز ساب‌کندرال (Subchondral sclerosis) بیشتر در استئوآرتریت (OA) دیده می‌شود، نه RA. لذا وجود اسکروز ساب‌کندرال با تشخیص RA مغایرت دارد.

۹- در تصویر رادیوگرافی مقابل چه یافته‌ای دیده نمی‌شود؟



الف) کاهش فاصله بین مهره‌ای

ب) اسکروز لبه مهره

ج) فرسایش یا خوردگی مهره

د) استئوفیت لبه قدامی و خلفی مهره

پاسخ تشریحی: گزینه ج

در رادیوگرافی ارائه شده، می‌توان مشاهده کرد که فاصله بین دیسک‌ها کاهش یافته است (ویژگی دژنراتیو)، لبه‌های مهره‌ها دارای زواید استخوانی (استئوفیت) هستند و در لبه‌های مهره‌ها اسکروز دیده می‌شود.

اما خوردگی مهره (erosion) که اغلب در بیماری‌های التهابی مانند اسپوندیلیت آنکیلوزان یا عفونت‌هایی مانند سل مهره‌ای دیده می‌شود، در این تصویر به چشم نمی‌خورد. مرز استخوانی مهره‌ها حفظ شده و نشانی از تخریب فعال استخوانی وجود ندارد.

۱۰- جوان ۲۵ ساله به علت کمردرد و درد و تورم مفاصل مچ دست و زانوی راست مراجعه نموده است. بیمار سابقه دردهای شکمی و اسهال را از حدود یک سال قبل ذکر می‌کند. در مورد این بیمار کدام مورد صادق نمی‌باشد؟

(الف) بیمار ممکن است به سمت AS (اسپوندیلیت آنکیلوزان) پیشرفت کند.

(ب) اسپوندیلوآرتریت سیری مستقل از التهاب روده دارد

(ج) پلی آرتریت سیری مستقل از التهاب روده دارد

(د) الیگوارتریت مرتبط با التهاب روده‌ای (IBD) سیری مستقل با التهاب روده دارد.

پاسخ تشریحی: گزینه د به نظر بنده

بیمار جوان با سابقه اسهال و درد شکمی مزمن، همراه با درد کمری و آرتریت محیطی (مچ دست و زانو)، تابلویی از آرتریت مرتبط با بیماری التهابی روده (IBD-related arthritis) دارد. در آرتریت مرتبط با IBD، درگیری ستون فقرات می‌تواند مستقل از بیماری روده باشد (شبیه به AS)، ولی درگیری مفاصل محیطی معمولاً سیری موازی با فعالیت بیماری روده‌ای دارد.

الف: درست است، چون درگیری محوری می‌تواند به اسپوندیلیت آنکیلوزان پیشرفت کند.

ب: جزوه در مورد اسپوندیلوآرتریت مرتبط با IBD، بین انواع درگیری تفکیک قائل شده‌اند. درگیری محوری مانند AS و پلی آرتریت مزمن و قرینه، سیری مستقل از فعالیت بیماری روده‌ای دارند. اما الیگوارتریت یا مونوآرتریت که با الگوی درگیری بیمار جوان ما که در مچ دست و زانوی راست درد و تورم دارد، همخوانی دارد، سیری موازی و مرتبط قوی با شعله‌ور شدن بیماری روده‌ای دارند. این جمله که "اسپوندیلوآرتریت سیری مستقل از التهاب روده دارد" به صورت کلی صادق نمی‌باشد (False)، زیرا شامل الیگوارتریت نیز می‌شود که سیری مستقل ندارد.

ج: درست است، پسوریاتیک آرتریت معمولاً ارتباطی با بیماری روده‌ای ندارد.

د: غلط است. درگیری مفاصل محیطی در IBD اغلب همراه با شعله‌ور شدن روده است.

۱۱- آقای جوان با سابقه کمردرد التهابی از یک سال قبل مراجعه کرده است. در معاینه حرکات کمر محدود شده و دردناک است. در لمس ساکروایلیاک دو طرف و قفسه سینه تندرنس وجود دارد. کدام اقدام تشخیصی ارجح است؟

(الف) CRP (C-reactive protein)

(ب) رادیوگرافی لگن

(ج) رادیوگرافی مهره‌های کمر

(د) ESR

پاسخ تشریحی: گزینه ب

بیمار مورد نظر دارای مشخصات کلاسیک اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) است:

- کمردرد التهابی (در جوانان، تدریجی، بهبود با فعالیت)
- محدودیت حرکات ستون فقرات
- تندرns در ناحیه ساکروایلیاک (نشانه درگیری مفصل ساکروایلیاک)
- کاهش انقباض قفسه سینه

مهمترین تست تشخیصی برای تایید درگیری ساکروایلیاک در این بیماران، رادیوگرافی لگن برای بررسی ساکروایلیت است، نه مهره‌های کمر. درگیری اولیه در AS معمولاً از مفاصل ساکروایلیاک شروع می‌شود

الف) تست آزمایشگاهی غیر اختصاصی است. ممکن است برای پایش التهاب استفاده شود ولی ارزش تشخیصی اولیه ندارد.

ب: درست‌ترین انتخاب است برای بررسی ساکروایلیت.

ج: در مراحل ابتدایی کمک زیادی نمی‌کند. مهره‌ها دیرتر درگیر می‌شوند.

د: مانند CRP فقط یک شاخص التهابی است، اما تشخیص‌دهنده نیست.

۱۲- نوع درگیری چشمی در آرتریت پسوریاتیک (Psoriatic Arthritis - PSA) بیشتر به چه شکل است؟

الف) یووئیت خلفی

ب) خستگی چشم

ج) کونژکتیویت

د) یووئیت قدامی

پاسخ تشریحی: گزینه الف

در یووئیت پسوریاتیک، شکل درگیری به صورت خلفی (posterior) و دوطرفه (bilateral) است. این نوع یووئیت مزمن می‌شود، پروگنوز بدتری دارد و بیشتر به سمت کوری پیش می‌رود.

درگیری چشمی در AS بیشتر به صورت یووئیت قدامی و معمولاً یک‌طرفه است.

نکته کلیدی	سیر بیماری	یک طرفه / دو طرفه	ناحیه درگیری (قدامی / خلفی)	نوع شایع یوئیت	بیماری / وضعیت
معیار تشخیصی مشترک در همه SpA	حاد	معمولاً یک طرفه	قدامی	یوئیت حاد دردناک	اسپوندیلوآرتروپاتی ها (SpA)
الگوی کلاسیک در AS	حاد	یک طرفه	قدامی	یوئیت حاد	اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS)
خطر کوری؛ شیوع حدود ۷-۳۳٪	مزمن، پروگنوز ضعیف	دو طرفه	خلفی	یوئیت مزمن	آرتریت پسوریاتیک (PSA)

۱۳- آقای ۴۰ ساله با سابقه ۱۰ ساله کمردرد التهابی مراجعه کرده است. در نمای رادیوگرافی کمر ایشان چه می بینید؟



الف) شکستگی

ب) مرضی شدن مهره ها

ج) بامبو اسپاین

د) استئوفیت

پاسخ: گزینه ج

تصویر رادیوگرافی مهره های کمری، نمایی دیده می شود که در آن استخوان های مهره به صورت پیوسته و بدون فضای دیسکی مشخص شده اند و خطوط سفید ممتدی دیده می شود. این نمای کلاسیک از "بامبو اسپاین" (bamboo spine) است که در اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) دیده می شود. این نمای به دلیل کلسیفیکاسیون رباط های طولی و ایجاد پل های استخوانی بین مهره ها (syndesmophytes) ایجاد می شود که ظاهری شبیه به بامبو به ستون فقرات می دهد.

۱۴- آقای ۲۱ ساله با درد و تورم و قرمزی مفاصل مچ پای راست، زانوی چپ و تاندون آشیل راست که از هفته قبل شروع شده، مراجعه کرده است. ایشان در سابقه غیر از عفونت ادراری یک ماه قبل که بهبود یافته، مشکل دیگری را ذکر نمی کند. عکس زیر مربوط به ایشان است. نام ضایعه چیست؟



پاسخ تشریحی:

بیمار مرد جوانی است با:

- درگیری حاد مفاصل بزرگ (مچ پا، زانو)
- التهاب محل اتصال تاندون (enthesitis) در آشیل
- ضایعه پوستی واضح در کف پا
- سابقه عفونت ادراری یک ماه قبل

این تابلوی بالینی کاملاً با آرتریت واکنشی (Reactive Arthritis) هم‌راستا است. ضایعه پوستی در کف پا که به وضوح در تصویر دیده می‌شود، ضایعه‌ای شایع در این بیماران است و به آن کراتودرما بلنوراجیکا (keratoderma blennorrhagica) گفته می‌شود.

۱۵- خانم ۳۰ ساله با سابقه آرتریت مفاصل PIP، DIP، و مچ (wrist) به همراه Pitting ناخن‌ها و ضایعات پوستی قرمز رنگ همراه با پوسته‌ریزی روی آرنج‌ها و زانو‌ها مراجعه کرده است. کدام عبارت زیر در مورد وی صحیح است؟

- الف) انکیلوز مفصلی شایع نیست.
- ب) داکتیلیت جز تظاهرات شایع بیماران است.
- ج) ۹۰٪ از بیماران HLA-B۲۷ مثبت دارند.
- د) درگیری پوستی ناخن اغلب همزمان با درگیری مفصلی رخ می‌دهد.

پاسخ تشریحی: گزینه

بر اساس شرح حال بیمار خانم ۳۰ ساله با آرتریت مفاصل PIP، DIP، و مچ، Pitting ناخن‌ها و ضایعات پوستی پسوریاتیک روی آرنج‌ها و زانو‌ها، تشخیص آرتریت پسوریاتیک (Psoriatic Arthritis - PsA) قویاً مطرح است

الف: آرتریت پسوریاتیک در مقایسه با آرتریت روماتوئید (RA) تمایل بیشتری به ایجاد انکیلوز (چسبیدن دو سطح استخوان) به صورت سریع Rapid ankylosis در مفاصل کوچک دارد. این نشان می‌دهد که انکیلوز در مفاصل کوچک در PsA رخ می‌دهد و حتی ممکن است سریع باشد

ب: داکتیلیت (انگشت سوسپسی) به عنوان یکی از تشخیص‌های افتراقی مهم برای PsA ذکر شده است. در بررسی پترن‌های درگیری مفصلی در PsA، الگوی اولیگوآرتریت نامتقارن (شایع‌ترین پترن طبق برخی رفرنس‌ها که ۳۰٪ موارد را شامل می‌شود) اغلب همراه با داکتیلیت است.

ج: در بیماران PsA که درگیری اگزپال (محوری) دارند، ۵۰٪ تا ۷۰٪ HLA-B۲۷ مثبت بوده‌اند، اما در بیماران با درگیری مفاصل محیطی، HLA-B۲۷ مثبت بودن کمتر از ۲۰٪ بوده است

د: درگیری ناخن ممکن است زودتر، همزمان یا دیرتر از آرتریت رخ دهد.

۱۶- آقای ۳۰ ساله با سابقه ۱۰ ساله کمردرد التهابی مراجعه کرده است. در نمای رادیوگرافی کمر ایشان چه می بینید؟



الف) شکستگی

ب) اسپوندیلولیزتیزیس

ج) سین دسموفیت (Syndesmophyte)

پاسخ تشریحی: گزینه ج

در تصویر رادیوگرافی ارائه شده، می توان مشاهده کرد که ساختارهای استخوانی باریک و عمود بر صفحه مهره ها (bridging syndesmophytes) بین مهره ها شکل گرفته اند که از لبه یک مهره به مهره مجاور کشیده شده اند. این نمای مشخصه سین دسموفیت است.

سین دسموفیت ها ساختارهایی استخوانی هستند که در نتیجه التهاب مزمن محل اتصال رباط ها (entheses) به استخوان ایجاد شده و از ویژگی های بارز بیماری هایی مانند اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) می باشند.

۱۷- کدام یک از موارد زیر جز تظاهرات رادیوگرافیک اسپوندیلیت آنکیلوزان نمی باشد؟

الف) مربعی شدن مهره ها

ب) درخشان شدن گوشه قدامی مهره

پ) التهاب مهره و دیسک بین مهره ای

د) کلسیفیکاسیون دیسک بین مهره ای

پاسخ تشریحی: گزینه د

اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) یکی از اسپوندیلوآرتروپاتی های التهابی مزمن است که درگیری محوری ستون فقرات، به ویژه مفاصل ساکروایلیاک و مهره های کمری را به همراه دارد. تظاهرات رادیولوژیک مشخص این بیماری شامل موارد زیر است:

- مربعی شدن مهره ها - (Squaring of vertebral bodies) به دلیل از بین رفتن تحدب طبیعی قدامی مهره

- درخشان شدن گوشه قدامی مهره ها - (Shiny corners or Romanus lesions) در مراحل اولیه بیماری

- سین دسموفیت و بامبو اسپاین - در مراحل پیشرفته تر

- التهاب دیسک و مهره (Spondylodiscitis) یا Andersson lesion می تواند در مواردی دیده شود، گرچه شایع نیست

اما کلسیفیکاسیون دیسک بین مهره‌ای از ویژگی‌های اصلی AS نیست و بیشتر در بیماری‌های دژنراتیو (مانند استئوآرتریت یا دژنراسیون دیسک) دیده می‌شود.

۱۸- آقای مبتلا به بیماری AS در مورد ابتلای پسرش به بیماری مشابه، با شما مشورت می‌کند. فرزند ایشان (مثبت) HLA-B۲۷ می‌باشد. احتمال ابتلای وی به بیماری AS چند درصد است؟

الف) ۶۵٪

ب) ۱۰٪-۳۰٪

پ) ۹۰٪

د) ۱٪-۶٪

پاسخ تشریحی: گزینه ب

اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) ارتباط قوی با آنتی‌ژن HLA-B۲۷ دارد. با این حال، داشتن HLA-B۲۷ به تنهایی به معنای ابتلا به AS نیست، بلکه فقط ریسک ابتلا را افزایش می‌دهد.

در جمعیت عمومی، حدود ۶٪-۸٪ افراد دارای HLA-B۲۷ هستند، اما فقط ۱٪-۲٪ آنها به AS مبتلا می‌شوند.

در فرزندان بیماران مبتلا به AS، اگر HLA-B۲۷ مثبت باشند، احتمال ابتلا در آن‌ها حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد است.

در دوقلوهای همسان هم ۶۵ درصد

۱۹- در آرتروپاتی انتروپاتیک کدام یافته زیر دیده می‌شود؟

الف) معمولاً HLA-B۲۷ مثبت است

ب) با فلیر بیماری مفصلی در نوع اسپوندیلیت آن، بیماری روده‌ای نیز شعله‌ور می‌شود.

ج) با فلیر بیماری مفصلی در نوع پلی‌آرتیکولار آن، بیماری روده‌ای نیز شعله‌ور می‌شود.

د) بیش از نیمی از بیماران AS درگیری نهفته دستگاه گوارش دارند.

پاسخ تشریحی: گزینه د

آرتروپاتی انتروپاتیک یکی از اسپوندیلوآرتروپاتی‌های مرتبط با بیماری التهابی روده (IBD) نظیر کولیت اولسروز و بیماری کرون است. این بیماری به دو شکل مفصلی بروز می‌کند:

- درگیری محیطی مفاصل (الیگوآرتیکولار): این نوع معمولاً با شعله‌ور شدن بیماری روده‌ای هم‌زمان است.

- درگیری محوری (شامل اسپوندیلیت و ساکروایلیت): این نوع مستقل از فعالیت بیماری روده‌ای است.

همچنین، طبق شواهد، در بیش از نیمی از بیماران مبتلا به AS (اسپوندیلیت آنکیلوزان) حتی در غیاب علائم گوارشی، درگیری نهفته روده‌ای (زیر بالینی) در بیوپسی گزارش شده است.

۲۰- خانم ۴۵ ساله‌ای به علت درد و تورم زانوها مراجعه کرده. در معاینه التهاب مفاصل DIP هر دو دست و برخی از مفاصل PIP و ضایعات ارتروماتوز پوسته‌ریزی دهنده در سطوح اکستنسور دیده می‌شود و در برخی از ناخن‌ها هیپرکراتوز و فرورفتگی‌هایی مشاهده می‌گردد. در آزمایشات RF و Anti-CCP منفی هستند. با توجه به این اطلاعات، بیمار در سیستم امتیازدهی CASPAR چند امتیاز می‌گیرد؟

الف) ۲ امتیاز

ب) ۳ امتیاز

ج) ۴ امتیاز

د) ۵ امتیاز

پاسخ تشریحی: گزینه

TABLE 362-2 The CASPAR (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis) Criteria^a

To meet the CASPAR criteria, a patient must have inflammatory articular disease (joint, spine, or enthesal) with ≥ 3 points from any of the following five categories:

1. Evidence of current psoriasis,^{b,c} a personal history of psoriasis, or a family history of psoriasis^d
2. Typical psoriatic nail dystrophy^e observed on current physical examination
3. A negative test result for rheumatoid factor
4. Either current dactylitis^f or a history of dactylitis recorded by a rheumatologist
5. Radiographic evidence of juxtaarticular new bone formation^g in the hand or foot

^aSpecificity of 99% and sensitivity of 91%. ^bCurrent psoriasis is assigned 2 points; all other features are assigned 1 point. ^cPsoriatic skin or scalp disease present at the time of examination, as judged by a rheumatologist or dermatologist.

^dHistory of psoriasis in a first- or second-degree relative. ^eOnycholysis, pitting, or hyperkeratosis. ^fSwelling of an entire digit. ^gIll-defined ossification near joint margins, excluding osteophyte formation.

Source: Reproduced with permission from W Taylor et al: Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 54:2665, 2006.

معیارهای CASPAR برای تشخیص آرتریت پسوریاتیک شامل موارد زیر است و حداقل ۳ امتیاز برای تشخیص لازم است:

۱. شواهد بیماری پوستی پسوریازیس:

○ در حال حاضر: ۲ امتیاز

○ سابقه یا سابقه خانوادگی: ۱ امتیاز

۲. درگیری ناخن: hyperkeratosis, pitting, onycholysis: ۱ امتیاز

۳. منفی بودن فاکتور روماتوئید (RF): ۱ امتیاز

۴. درگیری مفاصل DIP: ۱ امتیاز

۵. وجود ساکروایلایت یا پرهوژن استخوانی در رادیوگرافی: ۱ امتیاز

خودتون حساب کنید...

۲۱-آقای ۲۸ ساله با درد و تورم و قرمزی مفاصل مچ پای راست، زانوی چپ، و تاندون آشیل راست که از سه هفته قبل شروع شده مراجعه کرده است. در معاینه، زخم دهانی و وزیکول‌های هیپرکراتوتیک در کف پاها دارد. در رادیوگرافی لگن و مفاصل گرفتار یافته خاصی ندارد. در آزمایشات و شمارش سلول‌های خونی نیز مورد خاصی دیده نمی‌شود. کدام یک از تشخیص‌های زیر بیشتر برای بیمار مطرح است؟

الف) آرتریت راکتیو

ب) عفونت گنوکوکی منتشر

ج) اسپوندیلیت آنکیلوزان

د) لوپوس اریتمتوی سیستمیک

پاسخ تشریحی: گزینه الف

بیمار مرد جوانی است با:

- شروع ناگهانی علائم مفصلی پس از چند هفته از یک عفونت احتمالی (با توجه به سابقه نهفته زمانی)

- درگیری مفاصل محیطی پایین تنه (مچ پا و زانو) و تاندونیت (آشیل)

- ضایعات جلدی (وزیکول‌های هیپرکراتوتیک در کف پا - که با کراتودرما بلنورا/جیکا سازگار است)

- زخم دهانی

- آزمایشات خون و رادیولوژی طبیعی

این تابلوی بالینی با آرتریت راکتیو (Reactive Arthritis) کاملاً مطابقت دارد، که یک نوع از اسپوندیلوآرتروپاتی‌های سرونگاتیو است و اغلب در مردان جوان، به دنبال عفونت‌های ادراری یا گوارشی ایجاد می‌شود.

ب: معمولاً با تب و درگیری مفصلی حاد چند ناحیه‌ای و راش‌های پوستی خاص همراه است.

ج: درگیری اولیه معمولاً محوری است (ساکروایلایت) نه محیطی، و علائم پوستی ندارد.

د: معمولاً زنان را گرفتار می‌کند و با یافته‌های آزمایشگاهی مانند ANA، اختلالات هماتولوژیک و درگیری‌های سیستمیک همراه است.

۲۲-آقای ۳۰ ساله با سابقه کمردرد التهابی از ۶ ماه قبل به کلینیک روماتولوژی مراجعه کرده است. در MRI لگن انجام شده با تکنیک STIR ، ادم مغز استخوان در ساکروایلپاک گزارش شده است. کدام یافته زیر برای تشخیص اسپوندیلوآرتروپاتی در ایشان معیار نمی باشد؟

الف) سابقه یوئیت

ب) افزایش ESR

ج) سابقه IBD

د) آرتریت

پاسخ تشریحی: گزینه ب

TABLE 362-1 ASAS Criteria for Classification of Axial Spondyloarthritis (to be applied for patients with back pain ≥ 3 months and age of onset < 45 years) ^a		
SACROILIITIS ON IMAGING PLUS ≥ 1 SpA FEATURE	OR	HLA-B27 PLUS ≥ 2 OTHER SpA FEATURES
Sacroiliitis on imaging - Active (acute) inflammation on MRI highly suggestive of SpA-associated sacroiliitis^b and/or - Definite radiographic sacroiliitis according to modified New York criteria^c		SpA features: - Inflammatory back pain^d - Arthritis^e - Enthesitis (heel)^f - Anterior uveitis^g - Dactylitis^h - Psoriasisⁱ - Crohn's disease or ulcerative colitis^j - Good response to NSAIDs^k - Family history of SpA^l - HLA-B27 - Elevated CRP^m

مورد ب در جدول ذکر نشده

ابوالفضل جعفری_MEDQMUMS